

Tumeurs de l'œsophage

Pr Pierre-Emmanuel Colombo¹, Pr Julien Edeline², Pr Jérôme Doyen³, Dr Stéphanie Servagi Vernat⁴

¹Département de Chirurgie oncologique, ICM Val d'Aurelle, Montpellier

²Service d'Oncologie digestive, Centre Eugène Marquis, Rennes

³Service de Radiothérapie, Centre Antoine Lacassagne, Nice

⁴Service de Radiothérapie, Institut Jean Godinot, Reims

OBJECTIFS : N° 305. Tumeurs de l'œsophage

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur de l'œsophage.

1. Épidémiologie
 - 1.1. Connaître l'incidence et la prévalence des cancers de l'œsophage en France
 - 1.2. Pronostic
 - 1.3. Connaître les deux principaux types histologiques de cancer de l'œsophage
 - 1.4. Connaître les facteurs de risque et les principales lésions augmentant le risque de survenue ultérieure d'un cancer de l'œsophage
2. Histoire naturelle
3. Connaître les principales circonstances de découverte et les manifestations cliniques du cancer de l'œsophage
 - 3.1. Rarement de découverte fortuite
 - 3.2. Le plus souvent le diagnostic se fait sur des symptômes thoraciques
 - 3.3. Signes en rapport avec une extension loco-régionale (tumeurs localement avancées)
 - 3.4. Signes généraux (altération de l'état général = AEG)
- 3.5. Signes en rapport avec une extension métastatique révélatrice
4. Diagnostic de certitude : connaître les indications de la fibroscopie œsogastrique
5. Bilan pré-thérapeutique
 - 5.1. Examen clinique
 - 5.2. Connaître la stratégie d'exploration par imagerie d'une tumeur de l'œsophage
 - 5.3. Les autres examens complémentaires
 - 5.4. Bilan d'état général et d'opérabilité
6. Classification TNM des cancers de l'œsophage
7. Particularité des tumeurs de la jonction œsogastrique
8. Prise en charge thérapeutique
 - 8.1. Règles générales
 - 8.2. Présentation des différents traitements
 - 8.3. Effets indésirables des traitements
 - 8.4. Prise en charge nutritionnelle
9. Surveillance

Rang	Rubrique	Intitulé
B	Définition	Connaître les deux principaux types histologiques de cancer de l'œsophage
A	Étiologies	Connaître les principales lésions augmentant le risque de survenue ultérieure d'un cancer de l'œsophage
B	Épidémiologie	Connaître l'incidence et la prévalence des cancers de l'œsophage en France
A	Diagnostic positif	Connaître les principales circonstances de découverte et les manifestations cliniques du cancer de l'œsophage
B	Examens complémentaires	Connaître la stratégie d'exploration par imagerie d'une tumeur de l'œsophage
B	Examens complémentaires	Connaître les indications de la fibroscopie œsogastrique



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

- Le cancer de l'œsophage est un cancer relativement peu fréquent et de mauvais pronostic.
- Il convient de distinguer les deux types histologiques les plus fréquents : **les cancers épidermoïdes** en lien avec l'intoxication alcool-tabagique et **les adénocarcinomes**, le plus souvent liés à la dégénérescence d'un endobrachyœsophage et à l'obésité.
- L'épidémiologie se modifie depuis plusieurs années avec une augmentation relative de la fréquence des adénocarcinomes.
- Le diagnostic de cancer œsophagien doit systématiquement être évoqué devant une dysphagie progressive qui doit conduire à la réalisation d'une fibroscopie œsogastrique avec biopsies.
- Le diagnostic de certitude repose sur l'examen anatomo-pathologique des biopsies lésionnelles réalisées au cours de la fibroscopie œsogastrique.
- Des pathologies associées se développant sur le même terrain à risque doivent être systématiquement recherchées en cas d'intoxication alcool-tabagique (cancers ORL ou pulmonaire, cirrhose...).
- Le scanner thoraco-abdomino-pelvien est le premier examen complémentaire à réaliser après l'endoscopie.
- Le bilan pré-thérapeutique apprécie l'extension loco-régionale et l'extension à distance de la tumeur. Une évaluation de l'état général, nutritionnel et des comorbidités du patient est indispensable.
- Le sevrage de la consommation alcoolique et tabagique est un point essentiel de la prise en charge thérapeutique.

B 1. Épidémiologie

1.1. Incidence et prévalence des cancers de l'œsophage en France

Le cancer de l'œsophage est une tumeur d'incidence relativement **faible**, de mauvais pronostic, touchant plus particulièrement **les hommes de plus de 50 ans**.

- On dénombre environ 480 000 nouveaux cas de cancer de l'œsophage par an dans le monde. Il existe de grandes variations d'incidence avec des pays à forte incidence (continent asiatique, Chine, Iran...) et des pays à plus faible incidence (continent africain, États-Unis...). En Europe, l'incidence est considérée comme moyenne.
- En France, l'incidence est en diminution progressive depuis 30 ans avec 5 499 nouveaux cas estimés en 2023. Le taux d'incidence standardisé monde est de 6 cas pour 100 000 chez l'homme et de 1,6 cas pour 100 000 chez la femme (données 2023).
- Il représente 1,3 % des cancers et 10 % des cancers digestifs. C'est une maladie à prédominance masculine : le sex-ratio est de 4/1.
- L'incidence est en diminution chez les hommes alors qu'elle est stable ou en légère augmentation chez les femmes.
- On observe une variabilité régionale importante avec une incidence plus élevée dans le nord et le nord-ouest du pays (Bretagne et Normandie). Néanmoins, c'est dans ces régions que la baisse d'incidence est la plus importante (liée à la diminution de la consommation d'alcool).
- La majorité des cas sont diagnostiqués après 50 ans. L'âge médian au diagnostic est de 68 ans pour les hommes et de 70 ans pour les femmes (données 2023).

1.2. Pronostic

- Le pronostic général des cancers de l'œsophage est sombre. Il est responsable de 3 725 décès par an (données 2018). Le taux de mortalité a diminué ces dernières années parallèlement au taux d'incidence.
- La survie globale à 5 ans tous stades confondus est de l'ordre de 10 % - 15 %. Ce mauvais pronostic est lié notamment à son extension au diagnostic (> 60 % des cas sont diagnostiqués à un stade localement avancé ou métastatique). La survie reste mauvaise même en cas de stade localisé (taux de survie < 40 % à 5 ans). Elle est quasiment nulle à 5 ans en cas de stade métastatique (taux de survie < 5 % à 5 ans).

1.3. Principaux types histologiques de cancer de l'œsophage

- Deux types histologiques principaux sont retrouvés (Tableau 1) :
 - les **carcinomes épidermoïdes**, classiquement les plus fréquents ; leur fréquence est en diminution. Ces tumeurs peuvent siéger tout le long de l'œsophage et se localisent le plus souvent au niveau de ses 2/3 supérieurs. On note une association fréquente, synchrone ou métachrone, avec des cancers des voies aéro-digestives supérieures et broncho-pulmonaires ;
 - le deuxième type histologique est l'**adénocarcinome** dont la fréquence relative est en forte augmentation. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau du tiers inférieur. L'incidence de l'adénocarcinome a considérablement augmenté ces dernières années aux États-Unis et en Europe occidentale pour rejoindre voire dépasser celle du carcinome épidermoïde en diminution ;

Tableau 1. CANCER DE L'ŒSOPHAGE : TYPES HISTOLOGIQUES	
Cancers épidermoïdes	Adénocarcinomes
Incidence en diminution Homme > femme après 60 ans 1/3 supérieur et 1/3 moyen Facteurs de risque : Alcool – tabac +++ Comorbidités et cancers associés : – Cirrhose – BPCO – CHC – Cancers ORL et bronchiques	Augmentation relative Homme > femme 1/3 inférieur ++ Facteurs de risque : RGO chronique avec EBO¹ de type intestinal ++ – Obésité + – Rôle du tabac moins net
1 EBO : Endobrachyoesophage	

- les autres types histologiques sont rares : tumeurs neuro-endocrines, tumeurs stromales ...

A 1.4. Facteurs de risque et principales lésions augmentant le risque de survenue ultérieure d'un cancer de l'œsophage (Tableau 2)

Les facteurs de risque du cancer de l'œsophage dépendent du type histologique.

1.4.1. Carcinome épidermoïde

- Ils sont principalement liés à l'intoxication alcool-tabagique avec un lien direct entre le risque de cancer et l'importance de l'intoxication :
 - l'alcool : lien direct avec la consommation alcoolique avec un risque $\times 20$ en cas d'alcoolisme chronique ; risque accru pour les alcools consommés chauds ;
 - le tabac : risque $\times 5$ en cas de tabagisme actif ;

- l'association alcool - tabac ++ :
 - principal facteur de risque des cancers épidermoïdes ++
 - synergie du risque cancérogène : le risque est multiplié par 100 !
 - responsable de 90 % des carcinomes épidermoïdes ;
 - lien direct entre le risque et l'importance de l'intoxication alcool-tabagique.

• **Ce terrain nécessite de rechercher des comorbidités liées à l'intoxication alcool-tabac ++ :**

- **Cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS), cancer broncho-pulmonaire :**
 - Réalisation systématique d'un examen ORL avec **naso-fibroscopie +/- associée à une pan-endoscopie des VADS** et d'une **fibroscopie bronchique** lors du bilan initial des cancers épidermoïdes ;
- Bronchite chronique obstructive (BPCO) ;
- Pathologies hépatiques : hépatopathie alcoolique, **cirrhose** hépatique, **carcinome hépatocellulaire**...

- **autres facteurs de risque :**

- ATCD de cancer des VADS ++ : association épidémiologique avec un risque de cancer œsophagien × 30 ;
- radiothérapie médiastinale (antécédent de radiothérapie pour lymphome ou maladie de Hodgkin, cancer du sein irradié parfois de nombreuses années auparavant) ;
- lésions précancéreuses à risque de dégénérescence tardive (au bout de nombreuses années) :
 - achalasie = méga-œsophage idiopathique ;
 - brûlures caustiques ;
 - diverticules œsophagiens (Zenker) ;
 - sclérodermie ;
 - tylose (kératodermie palmoplantaire).
- facteurs alimentaires (boissons chaudes [thé, maté chaud en Amérique du Sud], carences protidiques) ;
- rôle discuté du virus HPV (*Human papilloma virus*) en l'absence d'intoxication alcool-tabac.

Tableau 2. CANCER DE L'ŒSOPHAGE : LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES

Cancer épidermoïde	Adénocarcinome
• Méga-œsophage idiopathique (= achalasie) • Œsophagite caustique • Diverticules œsophagiens (diverticule Zenker) • Sclérodermie • Œsophagite radique • Tylose	• Endobrachyœsophage (métaplasie intestinale) ++ • Évoluant vers la dysplasie de bas grade, puis de haut grade

1.4.2. Adénocarcinome

- Il provient le plus souvent de la transformation d'un endobrachyœsophage (EBO ou œsophage de Barrett) lui-même secondaire à un reflux gastro-œsophagien (RGO) chronique.
- L'adénocarcinome œsophagien est plus fréquent chez les patients en surpoids, obèses et/ou diabétiques de type 2. Il est alors lié à l'excès alimentaire, aux calories d'origine animale et à l'insuffisance d'activité physique.
- Le tabac est également un facteur de risque dans ce type histologique.

L'EBO est le facteur de risque principal de l'adénocarcinome +++.

Endobrachyœsophage (œsophage de Barrett)

- C'est la cicatrisation pathologique de la muqueuse œsophagienne sur des lésions d'**œsophagite peptique** (RGO chronique) avec remplacement (métaplasie) de l'épithélium **malpighien** du 1/3 inférieur en épithélium **glandulaire** cylindrique. La métaplasie glandulaire est fundique ou **intestinale**, cette dernière étant particulièrement à risque de dysplasie et de dégénérescence. La présence d'un EBO **multiplie par 30 à 100** le risque de cancer de l'œsophage par rapport à la population générale sans EBO et nécessite **une surveillance rapprochée par endoscopie et biopsies**. La plupart des adénocarcinomes sur EBO surviennent selon une séquence métaplasie intestinale/dysplasie de grade croissant/cancer :

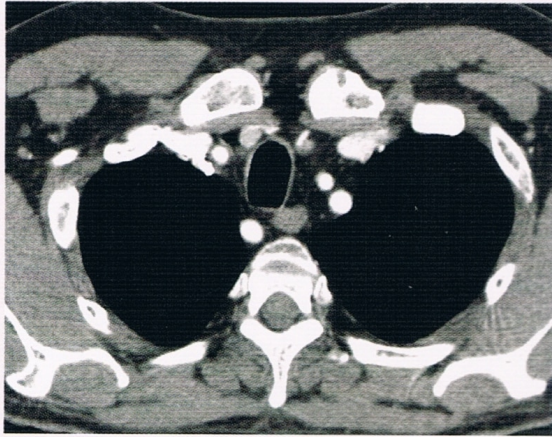
RGO chronique → œsophagite peptique → EBO (= métaplasie, sans dysplasie) → EBO avec dysplasie bas grade → EBO avec dysplasie de haut grade → dégénérescence en adénocarcinome

- **10 % des œsophagites peptiques évoluent vers l'EBO.**
- **10 % des EBO évoluent vers la dysplasie avec le risque de dégénérescence.**
- **But de la surveillance des EBO :** diagnostiquer tôt une dysplasie ou une lésion invasive débutante et améliorer la survie. Surveillance par endoscopies avec biopsies multiples étagées.
 - *Pas de dysplasie* : surveillance endoscopique tous les 2 à 5 ans (en fonction de la taille de l'EBO : endoscopies rapprochées en cas d'EBO long).
 - *Dysplasie de bas grade suspectée* : contrôle à 2 ou 3 mois après traitement par IPP à double dose (endoscopie + biopsies avec double lecture).
 - *Dysplasie de bas grade confirmée* : (endoscopie + biopsies étagées) tous les 6 mois la première année puis une fois/an.
 - *Dysplasie de haut grade* : contrôle à 1 mois ; si la dysplasie est confirmée (double lecture anatomo-pathologique) : traitement endoscopique (mucosectomie) ou chirurgical.

A 2. Histoire naturelle

- Le cancer de l'œsophage se développe à partir de l'épithélium œsophagien puis a une **extension en profondeur** dans la paroi infiltrant progressivement les différentes couches de l'organe jusqu'au tissu médiastinal péri-œsophagien. L'extension se fait alors vers les structures et organes médiastinaux adjacents (arbre trachéo-bronchique, péricarde, aorte...) (**Figures 1a-1b-1c**).
- L'extension est également longitudinale le long de l'organe vers le haut ou le bas (atteinte possible de la jonction œsogastrique et de l'estomac) avec possibilité de ponts de muqueuse saine.
- **L'extension lymphatique** est fréquente vers les ganglions péri-œsophagiens, médiastinaux, puis vers la petite courbure et la région cœliaque vers le bas ou les ganglions sus-claviculaires ou cervicaux vers le haut.
- L'extension **par voie hématogène** avec métastases à distance (poumon, foie, principalement puis os, cerveau...).
- Le développement de la tumeur entraîne une altération de l'état général et une **dénutrition** sévère jusqu'à la cachexie par **dysphagie** et évolution tumorale. Des infections médiastinales et pulmonaires et des pneumopathies d'inhalation sont fréquentes (fausses-routes, fistule œso-trachéale ou bronchique). Des **hématomés** sont possibles par rupture d'un gros vaisseau médiastinal.

Figure 1 a. Cancer de l'œsophage : corrélation anatomo-clinique

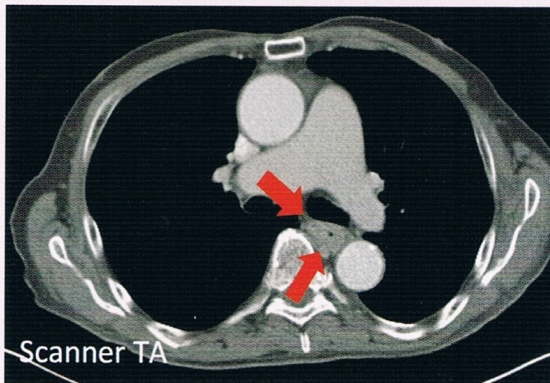


Tumeur du tiers-supérieur

- Se situe approximativement de l'orifice supérieur du thorax à la bifurcation trachéale (de 19 à 24 cm des arcades dentaires (AD)).
- Défilé étroit en arrière de la membraneuse trachéale.
- Extension rapide vers la membraneuse trachéale en avant.
- Puis vers les gros vaisseaux (tronc artériel brachio-céphalique (TABC), carotide), le nerf récurrent droit ou gauche.



Figure 1 b. Cancer de l'œsophage : corrélation anatomo-clinique



Tumeur du tiers-moyen

- Se situe sous la bifurcation trachéale de 25 à 32 cm des AD.
- Se situe dans un défilé étroit entre la face postérieure de la carène et la **bronche souche gauche ++**.
- En arrière peut envahir l'**aorte descendante**.
- Envahissement possible par la tumeur ou par des adénopathies métastatiques du nerf récurrent gauche (dysphonie par paralysie récurrentielle gauche).

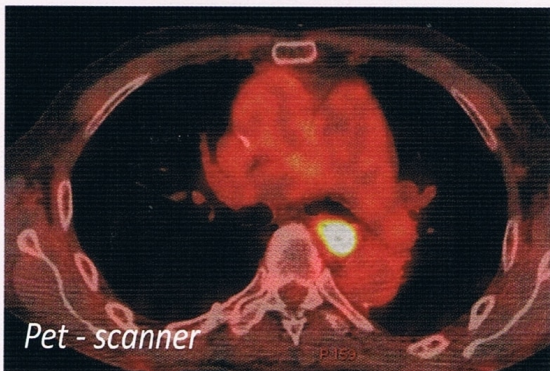
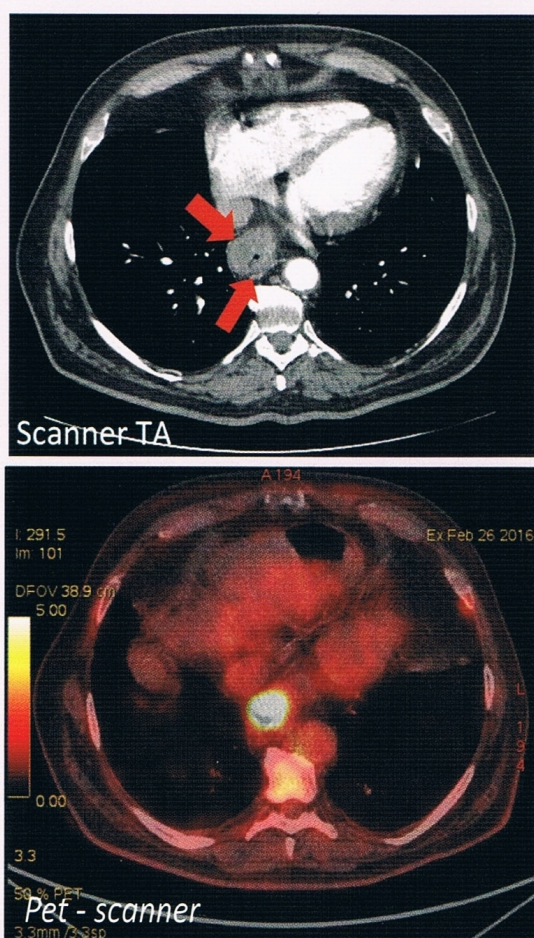


Figure 1 c. Cancer de l'œsophage : corrélation anatomo-clinique



Tumeur du tiers-inférieur

- Située de 32 cm à 40 cm des AD.
- À un stade évolué peut envahir **l'aorte** en arrière ou le **péricarde et le cœur** en avant.
- Extension verticale vers le bas vers la jonction œsogastrique et la petite courbure de l'estomac.

A 3. Principales circonstances de découverte et manifestations cliniques du cancer de l'œsophage

3.1. Rarement de découverte fortuite

- Ce cancer est longtemps asymptomatique ++, expliquant un diagnostic souvent tardif :
 - en France, il n'existe pas de protocole de dépistage organisé dans la population générale (contrairement aux pays asiatiques) ;
 - il peut être de découverte fortuite sur un bilan endoscopique ou radiologique : bilan endoscopique systématique en cas d'ATCD de cancer ORL, bilan de cirrhose, surveillance régulière d'un EBO (dépistage individuel)...

3.2. Le plus souvent le diagnostic se fait sur des symptômes thoraciques

- Témoins le plus souvent de tumeurs déjà avancées :
 - **dysphagie +++**, **organique**
C'est le principal signe clinique des cancers œsophagiens ++ ;
Elle est **progressive** : au début simple accrochage intermittent des aliments ; d'abord aux solides (initialement viande, croûte du pain...), puis aux liquides, puis aggravation jusqu'à l'aphagie complète ; permanente sans rétrocession.

Isolée, puis associée à des régurgitations, un hoquet, une haleine fétide (stase alimentaire), une **odynophagie** et des **douleurs thoraciques**.

- plus rarement : **hématémèse**.

TOUTE DYSPHAGIE PROGRESSIVE DOIT FAIRE RÉALISER UNE FIBROSCOPIE ŒSOGASTRODUODÉNALE (FOGD) AVEC BIOPSIES de toute lésion suspecte.

3.3. Signes en rapport avec une extension loco-régionale (tumeurs localement avancées)

- Syndromes médiastinaux (envahissement des structures médiastinales) :
 - **dysphonie** (voix bitonale et paralysie de la corde vocale gauche [par atteinte du nerf récurrent gauche]) ;
 - **toux à la déglutition** (2 mécanismes possibles : **fausse route** par paralysie de la corde vocale gauche [envahissement du nerf récurrent] – fistule trachéo ou broncho-œsophagienne) ;
 - surinfections pulmonaires à répétition ;
 - **douleurs thoraciques** rétro-sternales ou **inter-scapulaires**.

3.4. Signes généraux (altération de l'état général = AEG)

- Amaigrissement, asthénie, anorexie.
- Parfois unique signe d'appel.

Toute AEG importante chez un patient alcoolo-tabagique doit faire rechercher un cancer de l'œsophage.

3.5. Signes en rapport avec une extension métastatique révélatrice

- Adénopathie sus-claviculaire notamment gauche (ganglion de Troisier).
- Foie (**douleurs abdominales**, hépatomégalie nodulaire...).
- Poumon (**dyspnée**, épanchement pleural...).
- Os (**douleurs osseuses** inflammatoires, hypercalcémie...).

B 4. Diagnostic de certitude : indications de la fibroscopie œsogastrique

Le DIAGNOSTIC de certitude repose sur l'endoscopie +++ œsogastrique et l'examen anatomo-pathologique de biopsies.

- Fibroscopie œsogastrique ++
 - Patient à jeun, informé, après vérification du bilan d'hémostase, sous anesthésie locale ou générale.
 - Visualisation de la tumeur œsophagienne : aspect, étendue sur la circonférence, franchissable ou non (une tumeur non franchissable par l'endoscope est très souvent de stade $\geq$ T3 selon la classification TNM [voir ci-après]).

- TOPOGRAPHIE (distance / arcades dentaires), hauteur de la lésion, distance par rapport à la ligne Z (= jonction des muqueuses œsophagienne et gastrique).
- Permet la réalisation de biopsies multiples ++ avec examen anatomo-pathologique ++ : type histologique, grade selon l'OMS, évaluation de l'expression d'HER2 par immunohistochimie (pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique métastatiques).
- Cancers superficiels et dépistage en cas de lésions précancéreuses : le diagnostic est parfois difficile (intérêt des colorations ++ : bleu et Lugol, colorations virtuelles [NBI = narrow band imaging]).

B 5. Bilan pré-thérapeutique

C'est une étape primordiale de la prise en charge des cancers œsophagiens, car les modalités du traitement dépendent de paramètres essentiels que sont le type histologique, l'extension du cancer, l'état général et nutritionnel et les comorbidités du malade.

- Les objectifs du bilan pré-thérapeutique sont donc multiples :
 - Bilan d'extension (Figure 2) :
 - bilan d'extension local ;
 - bilan d'extension loco-régional ;
 - bilan d'extension à distance ;
 - Bilan général (comorbidités, pathologies associées) et évaluation du statut nutritionnel.
- Ce bilan permettra de déterminer le **stade**, le **pronostic** de la tumeur et son éventuelle opérabilité.

5.1. Examen clinique

- **Interrogatoire**
 - Antécédents et facteurs de risque (RGO, consommation **alcool**, **tabac** à quantifier)...
 - Comorbidités connues (ATCD de cancers [ORL, pulmonaire], hépatopathie, diabète, coronaropathie, BPCO...).
 - Signes fonctionnels (**dysphagie**, **douleur**, **toux** à la déglutition...).
 - Poids, IMC, perte de poids à quantifier.
 - Statut de performance OMS.
- **Examen clinique**
 - Signes en faveur d'une **extension loco-régionale importante** :
 - **dysphonie** (voie bitonale) par paralysie récurrentielle gauche (envahissement du nerf récurrent gauche par la tumeur ou des adénopathies métastatiques).
 - Signes en faveur d'une **extension métastatique** : **adénopathie sus-claviculaire gauche** (ou ganglion de Troisier, qui témoigne toutefois d'une extension loco-régionale et non à distance pour les carcinomes œsophagiens du tiers supérieur de l'œsophage ; à noter que le ganglion de Troisier se trouve parfois à droite).
 - Signes cliniques à la recherche de **comorbidités** : signes cliniques de cirrhose ou de BPCO...

3 signes cliniques sont évocateurs de tumeurs localement évoluées ou métastatiques non opérables :

- **toux** à la déglutition ;
- **dysphonie** (voie bitonale) par paralysie de la corde vocale gauche (envahissement du récurrent gauche) ;
- **adénopathie** sus-claviculaire gauche (Troisier).

5.2. Stratégie d'exploration par imagerie d'une tumeur de l'œsophage

5.2.1. Le scanner cervical et thoraco-abdomino-pelvien ++ (CTAP)

- Avec et sans injection de produit de contraste iodé (en l'absence d'allergie et après vérification de la fonction rénale).
- C'est le **premier examen à demander** après confirmation du diagnostic par la fibroscopie œsogastrique.
- Il évalue l'**extension loco-régionale** de la tumeur :
 - visualisation de la tumeur : localisation, hauteur...
 - rapport aux organes de voisinage ;
 - recherche des adénopathies médiastinales (fenêtres médiastinales).
- Il évalue l'**extension à distance** de la tumeur : adénopathies cervicales ou coeliaques, adénopathies mésentériques, métastases pulmonaires, métastases hépatiques...

5.2.2. Le TEP-TDM

- Examen non systématique.
- Non indiqué en cas d'extension métastatique évidente au scanner TAP.
- Imagerie morphologique et métabolique après injection de FDG marqué au fluor (TEP-TDM au 18-FDG).
- Participe au **bilan d'extension loco-régional** (adénopathies médiastinales) et à distance.
- **De plus en plus utilisé.**
- Dans certains cas, il permet l'évaluation de la réponse à une chimio-radiothérapie néo-adjuvante.

5.2.3. Échographie cervicale +/- biopsies ou cytoponction

- Non systématique.
- En cas d'adénopathie cervicale ou sus-claviculaire suspecte.

5.2.4. Transit œsophagien

- Non systématique.
- Permet de préciser la localisation et la hauteur de la tumeur et son extension sur l'estomac.
- Parfois demandé avant la chirurgie.

5.2.5. Scintigraphie osseuse et scanner/IRM cérébrale

- Non systématiques.
- Ces examens ne sont prescrits **que si point d'appel clinique ++**.
- Ils permettent de détecter des métastases à distance (cérébrales pour le scanner/IRM cérébrale et osseuses pour la scintigraphie).
- La scintigraphie osseuse n'est pas utile si un TEP-TDM au 18-FDG a été réalisé auparavant, car cet examen permet de détecter également les métastases osseuses.

5.3. Les autres examens complémentaires

5.3.1. L'écho-endoscopie œsophagienne

- Examen non systématique (elle n'est pas indiquée en présence d'une tumeur manifestement localement avancée ou métastatique).
- Évalue avec précision l'extension pariétale de la tumeur (T) et l'extension ganglionnaire loco-régionale (N).
- Peut guider la biopsie d'adénopathies médiastinales suspectes (biopsies trans-œsophagiennes).
- N'est possible que pour une tumeur franchissable (les tumeurs non franchissables sont le plus souvent de stade avancé $\geq T3$).
- Intéressante dans les tumeurs superficielles pour différencier un stade intra-muqueux d'un stade sous-muqueux.

5.3.2. Examen ORL : naso-fibroscopie et pan-endoscopie des voies aérodigestives supérieures

- Recherche de cancers associés.
- **SYSTÉMATIQUEMENT** indiqué dans les cancers épidermoïdes quelle que soit la localisation (également dans les adénocarcinomes chez un patient fumeur) pour rechercher un second cancer ORL associé.
- La naso-fibroscopie permet d'examiner les fosses nasales, le larynx et le pharynx en consultation.
- La pan-endoscopie est un examen sous anesthésie générale, de deuxième intention, qui permet d'examiner en plus les 2/3 supérieurs de l'œsophage et l'arbre trachéo-bronchique ainsi que la réalisation de biopsies.
- **Recherche une paralysie récurrentielle** (cancers du 1/3 moyen ou supérieur).
- Non indiqué pour les adénocarcinomes du 1/3 inférieur chez le non-fumeur.

5.3.3. Fibroscopie trachéo-bronchique

- **Extension loco-régionale** : indication systématique pour les deux types histologiques dans les cancers du tiers supérieur et du tiers moyen pour rechercher une extension à la trachée (1/3 supérieur), la carène ou à la bronche souche gauche (1/3 moyen).
- **Recherche de cancers associés** : systématiquement indiquée dans les cancers épidermoïdes (également dans les adénocarcinomes chez un patient fumeur) pour rechercher un second cancer bronchique associé.
- Non indiquée pour les adénocarcinomes du 1/3 inférieur chez le non-fumeur.

NE PAS OUBLIER DE RECHERCHER DES CANCERS ASSOCIÉS EN CAS DE CARCINOME ÉPIDERMOÏDE (20 % de cancers associés synchrones).

5.3.4. Marqueurs tumoraux

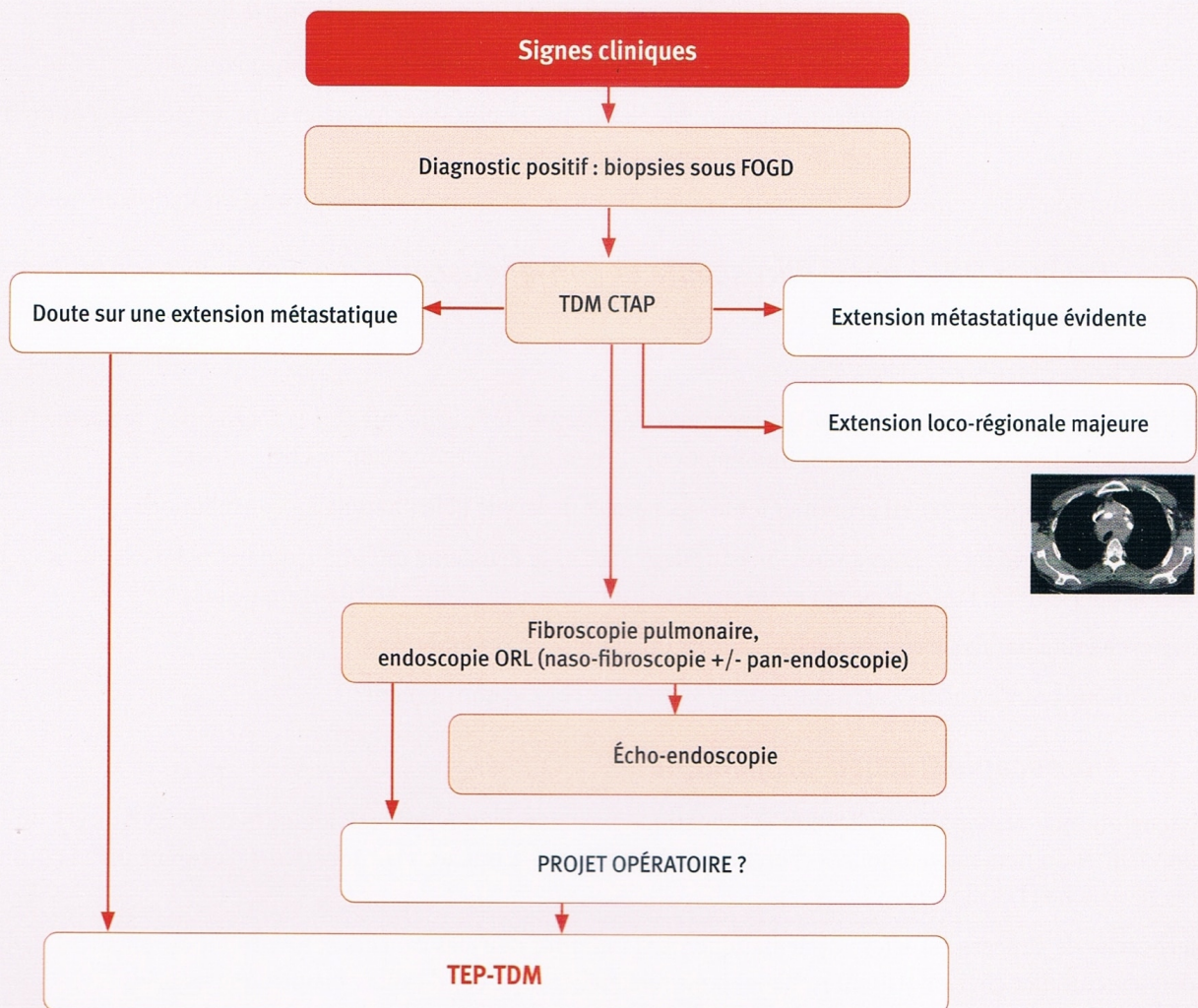
- Non systématiques.
- SCC pour les cancers épidermoïdes, ACE et CA19-9 pour les adénocarcinomes.
- Ils n'ont pas d'indication pour le diagnostic ++.
- Mais sont utilisés pour le suivi du patient s'ils sont élevés initialement.

5.3.5. Laparoscopie exploratrice

- Non systématique.
- Conseillée dans le bilan initial des adénocarcinomes œsophagiens ou de la jonction œsogastrique à la recherche d'une carcinose péritonéale.

- Chez un patient semblant, par ailleurs, accessible à un traitement curatif.
- En l'absence d'extension péritonéale évidente sur le bilan radiologique.

Figure 2. Bilan d'extension d'un cancer de l'œsophage
Comment hiérarchiser les examens....



5.4. Bilan d'état général et d'opérabilité ++

- Il évalue le terrain, l'état général et nutritionnel et apprécie la faisabilité des différentes options thérapeutiques.

5.4.1. Bilan général et pré-opératoire

- Clinique : évaluation du statut de performance OMS et examen général.
- Bilan cardio-vasculaire :
 - Consultation cardiologique, ECG, échographie cardiaque trans-thoracique...
 - Bilan respiratoire :
 - explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) +++
 - gazométrie artérielle.
- Fonction hépatique.
- Fonction rénale.

5.4.2. Bilan nutritionnel ++

- Essentiel dans le bilan initial et dans le suivi ++ :
 - Clinique : poids, indice de masse corporelle (IMC) et pourcentage d'amaigrissement par rapport au poids de forme. **La perte de poids d'au moins 10 % témoin d'une dénutrition sévère est un facteur de mauvais pronostic.**
 - Biologie : protidémie, albuminémie, pré-albuminémie.

5.4.3. Consultation d'aide au sevrage tabagique et alcoolique

- Consultation d'aide au sevrage tabagique et alcoolique.

La classification TNM des cancers de l'oesophage ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

6. Classification TNM des cancers de l'œsophage

- La classification TNM (7^e édition) ne considère plus comme métastases les **adénopathies** coeliaques (qui sont considérées comme régionales). Par ailleurs, les **adénopathies** sus-claviculaires gauches ne sont pas des adénopathies métastatiques mais loco-régionales pour les carcinomes du tiers supérieur de l'œsophage.

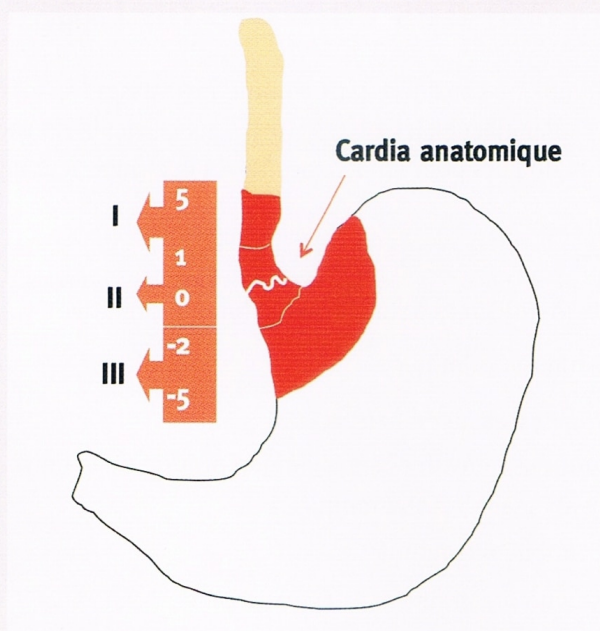
T	Tumeur primitive
Tx	Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive
To	Pas de signe de tumeur primitive
Tis	Carcinome <i>in situ</i> /dysplasie de haut grade
T1	T1a : Tumeur muqueuse envahissant la lamina propria ou la musculaire muqueuse T1b : Tumeur envahissant la sous-muqueuse
T2	Tumeur envahissant la musculature
T3	Tumeur envahissant l'adventice
T4	T4a : Tumeur envahissant la plèvre, le péricarde ou le diaphragme T4b : Tumeur envahissant les autres structures adjacentes telles que l'aorte, le corps vertébral ou la trachée
N	Adénopathies régionales
Nx	Renseignements insuffisants pour classer les adénopathies
No	Pas de signe d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
N1	Métastases dans 1-2 ganglions lymphatiques régionaux
N2	Métastases dans 3-6 ganglions lymphatiques régionaux
N3	Métastases dans 7 ou plus ganglions lymphatiques régionaux
M	Métastases à distance
Mo	Pas de métastase à distance
M1	Présence de métastase(s) à distance

La classification de Siewert ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

7. Particularités des tumeurs de la jonction œsogastrique

- La distance entre l'épicentre de la tumeur et le cardia anatomique détermine le type selon la classification de Siewert (**Figure 3**) :
 - **Type I** : tumeur dont l'épicentre est situé entre 5 à 1 cm au-dessus du cardia anatomique. Ils sont apparentés aux cancers de l'œsophage et partagent des modalités de diagnostic et de traitement identiques ;
 - **Type II** : tumeur dont l'épicentre est situé entre 1 cm au-dessus à 2 cm en dessous ;
 - **Type III** : tumeur dont l'épicentre est situé de 2 à 5 cm en dessous du cardia anatomique.

Figure 3. Classification de Siewert pour les tumeurs de la jonction œsogastrique



Le traitement des cancers de l'œsophage ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

8. Prise en charge thérapeutique

- Il nous a paru important de rapporter les grands principes de la prise en charge, **les effets secondaires** des traitements et également les modalités des **traitements symptomatiques** (cf. items 251 et 294).

8.1. Règles générales

- La stratégie thérapeutique des cancers de l'œsophage relève d'une **approche multidisciplinaire**, s'attachant à associer les prises en charge chirurgicales et médicales, mais également les traitements spécifiques et les soins de support.
- Les indications des différentes stratégies sont complexes, varient selon le type histologique, la localisation, le stade tumoral et les éventuelles comorbidités du patient. Cette complexité sous-entend la nécessité d'une **prise en charge en centre spécialisé**.

Le traitement des cancers de l'œsophage est multidisciplinaire. Il varie en fonction de l'extension, du stade de la tumeur et également de l'état général du patient.

- Chaque dossier est discuté en RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) avant toute prise en charge thérapeutique :
 - Élaboration du PPS : programme personnalisé de soins remis au patient et adressé au médecin traitant.
 - Information du malade :
 - sur l'histoire naturelle de sa maladie ;
 - sur le rapport bénéfice/risque des actes thérapeutiques ainsi que les alternatives possibles ;
 - dispositif d'annonce médical et infirmier.
- Une évaluation oncogériatrique sera faite pour tout patient âgé de plus de 70 ans.

8.2. Présentation des différents traitements (Figure 4)

8.2.1. Principes de la chirurgie des cancers de l'œsophage

- La chirurgie des cancers œsophagiens est une chirurgie complexe associée à une morbidité élevée (30 à 50 %) et une mortalité significative (< 5-10 % dans les centres experts). Elle n'est envisageable que pour une minorité des patients atteints d'un cancer œsophagien (10 à 30 %).
- **Règles générales** : elle comprend une exérèse œsogastrique plus ou moins étendue associée à une médiastinectomie postérieure monobloc et à un curage ganglionnaire (curage médiastinal, de la petite courbure et ganglions coeliaques...) suivis d'une reconstruction digestive. L'estomac est l'organe de remplacement le plus souvent utilisé par tubulisation gastrique (= gastroplastie). Cette chirurgie nécessite souvent plusieurs voies d'abord (abdominale, thoracique, cervicale...).
- **L'intervention de Lewis-Santy** est l'intervention de référence. Elle comporte une œsophagectomie avec gastrectomie polaire supérieure par double voie (abdominale et thoracique droite). La reconstruction se fait par gastroplastie et anastomose œsogastrique intra-thoracique haute. Elle est applicable pour les tumeurs du 1/3 moyen et 1/3 inférieur.
- Les cancers du tiers supérieur sont très rarement chirurgicaux, l'opération étant le plus souvent remplacée par une chimio-radiothérapie exclusive.

La chirurgie des cancers œsophagiens doit être réservée à des équipes entraînées dans des centres experts.

8.2.2. Principes de la radiothérapie et de la chimio-radiothérapie (RCT) dans le cancer de l'œsophage

- Elle est utilisée en situation curative en association à la chirurgie (néo-adjuvant) ou en remplacement (RCT exclusive = sans chirurgie).
- Elle peut être également utilisée en situation palliative à visée symptomatique.
- Elle dure 5 semaines à raison de 5 séances par semaine, une séance par jour.
- Elle est le plus souvent associée à une chimiothérapie de type carboplatine-paclitaxel en pré-opératoire, ou sinon FOLFOX (5FU, oxaliplatine) si la chimio-radiothérapie est exclusive (pas de chirurgie).

8.2.3. Principes de la chimiothérapie dans les cancers de l'œsophage

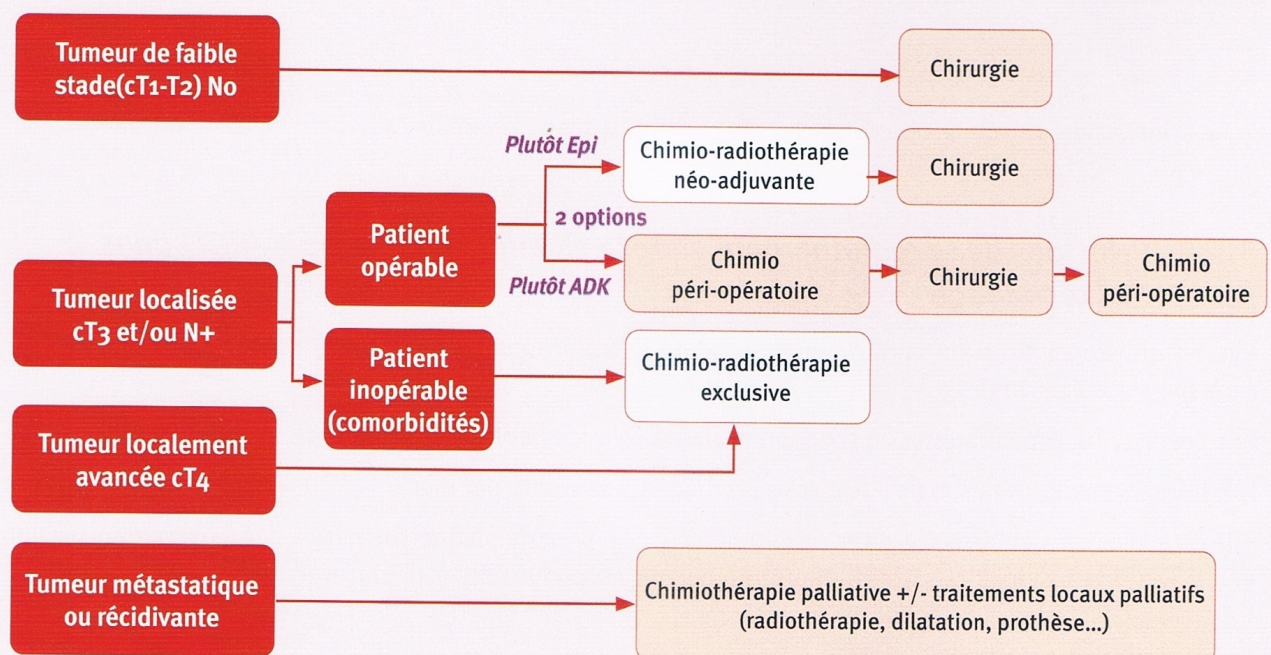
- La chimiothérapie fait appel le plus souvent à des associations comportant du 5-fluorouracile et un sel de platine. Elle comprend soit un schéma de type FOLFOX (5FU, oxaliplatine), ou cisplatine -5FU, parfois un schéma de type carboplatine-paclitaxel.
- La chimiothérapie est bien validée en situation d'association à un traitement à visée curative (traitement péri-opératoire, association à la radiothérapie). Par contre, l'effet est plus incertain et modeste en situation avancée. Elle doit alors être utilisée en complément des soins de support, dans une démarche d'intégration à des soins palliatifs précoces chez ces patients souvent très symptomatiques sur le plan digestif, voire respiratoire.
- L'immunothérapie devrait être bientôt disponible en situation avancée et adjuvante, en association aux autres traitements, ayant démontré son intérêt dans plusieurs études de phase 3.

8.2.4. Traitement endoscopique

8.2.4.1. À visée curative

- Une résection muqueuse endoscopique peut constituer un traitement à visée curative des cancers superficiels à faible risque d'atteinte ganglionnaire. Le risque d'atteinte ganglionnaire varie en fonction du type histologique (CE ou ADK), de la profondeur d'invasion, du grade de différenciation et de la présence ou non d'embolies lympho-vasculaires.
- Pour le carcinome épidermoïde, le traitement endoscopique sera réservé aux lésions superficielles M1 ou M2 n'atteignant pas la musculaire muqueuse pour lesquelles le risque d'atteinte ganglionnaire est quasi-nul. À partir de lésions plus profondes, M3 (atteinte de la musculaire muqueuse) ou SM1, le risque d'extension ganglionnaire justifie d'une résection chirurgicale.
- Pour l'adénocarcinome, un traitement endoscopique peut être proposé en cas de carcinome intra-muqueux (M1-M3) ou de lésion **SM1 bien différenciée et sans embolies**.
- La résection doit être réalisée de façon monobloc avec des marges latérales et profondes de sécurité. La dissection sous muqueuse est préférée à la mucosectomie. Si les critères histologiques ne sont pas respectés sur l'analyse définitive, une prise en charge chirurgicale complémentaire doit être discutée. Cette prise en charge doit être discutée avec des équipes expertes en endoscopie et en collaboration avec l'équipe chirurgicale.

Figure 4. Arbre décisionnel du traitement des tumeurs œsophagiennes



8.2.4.2. À visée symptomatique ou palliative

- Le traitement endoscopique est très utile dans la prise en charge des cancers œsophagiens à visée symptomatique en complément des autres traitements ou à visée palliative : prise en charge de la dysphagie par dilatations œsophagiennes, mise en place d'endoprothèses, techniques de destruction tumorale, mise en place d'une gastrostomie percutanée endoscopique...

8.3. Effets indésirables des traitements

8.3.1. Complications de la chirurgie

- Mortalité < 5-10 % dans les services spécialisés.
- 30 à 50 % de complications :
 - Complications post-opératoires :
 - essentiellement respiratoires : pneumopathies, syndrome de détresse respiratoire...
 - fistule œsophagienne avec risque de médiastinite.
 - À distance :
 - troubles fonctionnels digestifs (par perte du réservoir gastrique), satiété précoce, syndrome du petit estomac, dénutrition ;
 - sténose anastomotique ;
 - reflux gastro-œsophagien.

8.3.2. Complications de la chimiothérapie

- Complications communes : nausées, vomissements, toxicité hématologique, alopecie.
- Complications spécifiques :
 - sels de platine : neuropathies périphériques, paresthésies ; ototoxicité (cisplatine) ; toxicité rénale chronique (cisplatine)
 - 5-FU : mucite, syndrome main-pieds.

8.3.3. Complications de l'immunothérapie

- Les effets secondaires de l'immunothérapie sont marqués par des réactions auto-immunes qui peuvent toucher tous les organes.

8.3.4. Principaux effets secondaires de la RTCT

- Les effets secondaires de la radiothérapie se limitent en regard de la zone irradiée. On distingue :
 - les effets secondaires **aigus**, dus aux tissus à renouvellement rapide, qui sont réversibles après le traitement ;
 - et les effets secondaires **chroniques**, dus aux tissus à renouvellement lent, pouvant être irréversibles.
- En cours de RTCT, la prise en charge nutritionnelle est capitale du fait de la **dysphagie** provoquée par la maladie et par la radiothérapie ++++.
- Complications de l'irradiation : ce sont celles des irradiations thoraciques et abdominales (en cas d'irradiation d'un cancer du tiers inférieur) :
 - pneumopathie et alvéolite radique (toux, asthénie, douleur thoracique, dyspnée) ;
 - œsophagite ++++ (douleur à la déglutition = **odynophagie** puis **dysphagie**) : l'irradiation permet au début du traitement de nettement améliorer les symptômes locaux liés au cancer qui, ensuite, se ré-aggravent de façon systématique à cause de l'œsophagite radique ;
 - péricardite, épanchement pleural ;
 - surinfection mycotique de l'œsophagite ;

- les complications radiques disparaissent après arrêt de l'irradiation, avec toutefois possibilité de séquelles minimales à modérées, à moyen ou long terme : alvéolite et/ou œsophagite tardive avec sténose, coronaropathies, péricardite chronique, et rarement cancers radio-induits (après 5 ans).
- Traitement des complications radiques :
 - une corticothérapie permet de diminuer les symptômes et de poursuivre l'irradiation ;
 - tout comme l'utilisation d'antiacides (inhibiteurs de la pompe à protons, alginates de sodium) ;
 - ou celle des antimycotiques (fluconazole).

8.4. Prise en charge nutritionnelle

- À tous les stades de la maladie, la prise en charge nutritionnelle a une importance capitale. Le degré de dénutrition a un impact sur le pronostic de la maladie, sur les effets indésirables des traitements entrepris, et est responsable d'une dégradation de la qualité de vie.
- La première étape est le diagnostic nutritionnel. En plus des données cliniques (poids actuel, poids de base, % de perte de poids) et paracliniques (albumine, pré-albumine), l'interrogatoire nutritionnel, aidé par un(e) diététicien(ne), permet de quantifier les apports.
- La prise en charge dépend du degré de dénutrition, de la dysphagie ainsi que des risques d'aggravation par les traitements envisagés (majoration de la dysphagie en aigu lors de la radiothérapie). On privilégiera toujours la méthode de réalimentation la plus naturelle possible :
 - **optimisation des apports par voie orale.** En plus de conseils nutritionnels d'enrichissement de l'alimentation, les compléments nutritionnels hypercaloriques sont faciles à ingérer même en cas de dysphagie. Des adaptations nutritionnelles sont parfois également nécessaires après chirurgie (fractionnement des repas).
 - **alimentation entérale.** À privilégier, habituellement par gastrostomie (posée par voie endoscopique ou radiologique).
 - **alimentation parentérale.** Elle est réalisée sur voie veineuse centrale, expose à des risques infectieux et est plus limitée en termes d'apports caloriques. Ne doit être utilisée que par courtes périodes.
- La prise en charge est débutée précocement, dès avant la mise en route des traitements spécifiques. Son bon déroulement doit être surveillé de manière régulière, le principal critère d'évaluation étant la courbe pondérale.

9. Surveillance

- Le cancer de l'œsophage est associé à un fort risque de récurrence après traitement à visée curative. Cependant, la plupart des récurrences ne sont pas accessibles à un traitement curatif. Pour cette raison, l'intérêt de la réalisation d'examens complémentaires systématiques est débattu.

• Les 3 objectifs du suivi sont :

- le diagnostic d'une récurrence ;
- le diagnostic d'un second cancer ;
- la prise en charge des effets secondaires et séquelles des traitements.

La surveillance va s'appuyer essentiellement sur une surveillance clinique.

- En plus de la réapparition de symptômes, on s'attachera à vérifier le bon état nutritionnel. Chez les patients pouvant bénéficier d'un traitement de rattrapage (reprise chirurgicale, radiothérapie), une surveillance endoscopique (fibroscopie œsogastrique) et par scanner CTAP peut être proposée. Le rythme de surveillance est actuellement discuté. Un examen clinique et un scanner CTAP seront proposés tous les 4 à 6 mois pendant 2 ans puis tous les 6 mois pendant 3 ans. La FOGD sera réalisée à 2 ans en cas de chirurgie ou tous les 4 mois les 2 premières années en cas de chimio-radiothérapie exclusive. La surveillance est généralement planifiée pour 5 ans après la fin du traitement. En cas de cancer épidermoïde, un examen ORL annuel est indiqué.

Il conviendra également de dépister un deuxième cancer métachrone (surtout ORL) chez les patients atteints de cancer épidermoïde (examen ORL annuel).

- Chez ces patients, la prise en charge s'efforcera également de limiter l'exposition aux facteurs de risque, notamment par les conseils de prise en charge du tabagisme et de la consommation excessive d'alcool.

Principales situations de départ en lien avec l'item 305 : « Tumeurs de l'œsophage »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention	
313. Prévention des risques liés à l'alcool	Le cancer de l'œsophage est un cancer de mauvais pronostic. Le tabagisme, la consommation d'alcool et l'association alcool-tabac sont les premiers facteurs étiologiques du carcinome épidermoïde de l'œsophage et de certains adénocarcinomes. L'alcool et le tabac ont un effet synergique sur le risque de développement d'un cancer épidermoïde de l'œsophage. Le dépistage du cancer de l'œsophage n'est pas recommandé en France. Toute AEG importante chez un patient alcoolo-tabagique doit faire rechercher un cancer de l'œsophage. Le carcinome épidermoïde de l'œsophage est fréquemment associé à des comorbidités liées à l'intoxication alcool-tabac (cancers liés épidémiologiquement (cancers des voies aéro-digestives supérieures, cancer broncho-pulmonaire), BPCO, cirrhose...).
314. Prévention des risques liés au tabac	
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	
En lien avec le diagnostic de cancer de l'œsophage	
Signes en rapport avec l'extension thoracique de la tumeur	
52. Odynophagie/dysphagie	La dysphagie est le principal signe clinique des cancers œsophagiens. Il s'agit d'une dysphagie organique d'aggravation progressive jusqu'à l'aphagie, sans rétrocession. Elle est isolée ou associée à d'autres symptômes (régurgitation, hoquet, odynophagie, douleur thoracique...). Toute dysphagie progressive impose la réalisation d'une fibroscopie œsogastroduodénale. Plus rarement, le diagnostic se fait sur des hématémèses ou des signes d'hémorragie digestive (méléna, anémie ferriprive...). À un stade localement avancé, le cancer de l'œsophage peut être diagnostiqué sur des symptômes témoins d'une extension loco-régionale (dysphonie par paralysie récurrentielle gauche, toux à la déglutition par fausse-route ou fistule œso-trachéale ou œso-bronchique).
146. Dysphonie	
14. Émission de sang par la bouche	
13. Nausées/vomissements	
162. Dyspnée	
161. Douleur thoracique	
167. Toux	
10. Méléna/rectorragie	
214. Anomalie des indices érythrocytaires (taux hémoglobine, hématocrite...)	
Signes généraux et/ou en rapport avec une extension métastatique	
158. Tuméfaction cervico-faciale	L'altération de l'état général (asthénie, amaigrissement, anorexie) est parfois le seul signe clinique d'appel d'un cancer de l'œsophage. Toute AEG importante chez un patient alcoolo-tabagique doit faire rechercher un cancer de l'œsophage. La dysphagie entraîne rapidement un amaigrissement et une dénutrition qui seront à prendre en charge de façon spécifique. L'extension métastatique peut être également révélatrice : adénopathie sus-claviculaire gauche (ganglion de Troisier), métastases hépatiques, pulmonaire ou osseuses révélatrices...
16. Adénopathie(s) unique ou multiples	
17. Amaigrissement	
21. Asthénie	
30. Dénutrition/malnutrition	

En lien avec le bilan du cancer de l'œsophage	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	Le diagnostic de certitude repose sur l'endoscopie/fibroscopie œsogastrique+++ et l'examen anatomopathologique de biopsies. La fibroscopie apprécie la localisation de la lésion, son aspect, sa hauteur, sa topographie par rapport aux arcades dentaires et à la jonction œsogastrique. Deux types histologiques sont les plus fréquemment retrouvés sur l'examen anatomopathologique des biopsies : les carcinomes épidermoïdes et l'adénocarcinome dont la prise en charge thérapeutique est potentiellement différente. L'analyse d'HER2 par immunohistochimie est utile pour les adénocarcinomes du tiers inférieur et de la jonction œsogastrique métastatiques. Le scanner cervical et thoraco-abdomino-pelvien, sans et avec injection de produit de contraste iodé (en l'absence d'allergie et après vérification de la fonction rénale), est le premier examen à demander après confirmation du diagnostic par la fibroscopie œsogastrique. Il visualise la tumeur (localisation, hauteur...), évalue son extension loco-régionale et ses rapport aux organes de voisinage (arbre trachéo-bronchique, aorte, péricarde...) et recherche une extension ganglionnaire (péri-œsophagienne, médiastinale, cervicale, cœliaque...) ou métastatique (poumon, foie, adénopathies distales...). L'écho-endoscopie œsophagienne est un examen utile pour apprécier l'extension loco-régionale (extension pariétale et ganglionnaire) de la tumeur ou dans le bilan précis de tumeurs superficielles. Elle peut guider la biopsie d'éventuelles adénopathies médiastinales. Elle n'est possible qu'en cas de tumeur franchissable. Le TEP-TDM au 18-FDG, est un examen non systématique mais dont la prescription est croissante. Il n'est pas indiqué en cas d'extension métastatique évidente au scanner TAP. Il participe en complément du scanner au bilan d'extension loco-régionale (adénopathies médiastinales) et à distance (adénopathies cervicales et cœliaques, métastases foie, poumon, os...). Il est particulièrement utilisé pour le ciblage en cas de radiothérapie, pour la recherche d'une contre-indication opératoire en cas de chirurgie programmée et également en cas de doute sur une lésion métastatique sur le scanner.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
233. Identifier/reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
238. Demande et préparation aux examens endoscopiques (bronchiques, digestifs)	
239. Explication pré-opératoire et recueil de consentement d'un geste invasif diagnostique ou thérapeutique	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomopathologie	

